

Principios éticos en investigación en salud

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

La **investigación en salud** es esencial para generar conocimiento científico y mejorar la atención médica. Sin embargo, su desarrollo implica **responsabilidades éticas** fundamentales hacia las personas y comunidades que participan.

Los **principios éticos en investigación** garantizan que el avance científico se realice **respetando la dignidad, los derechos y el bienestar** de los participantes. En Chile, estos principios se encuentran regulados por **normativas nacionales** y por **instrumentos internacionales** adoptados por el país, como la **Declaración de Helsinki** y las **Guías CIOMS**.

En el contexto del **EUNACOM**, este tema es clave porque el médico general puede participar en proyectos de investigación, evaluación de políticas o estudios clínicos en su práctica profesional o académica. Por ello, debe conocer los **fundamentos éticos, legales y científicos** que rigen la investigación biomédica en Chile.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. Definición de investigación en salud

Según la **OMS**, la investigación en salud es “la generación sistemática de conocimiento para mejorar la salud de las poblaciones, sus servicios y políticas”.

En Chile, el **Reglamento N.º 114/2011 del MINSAL** define la investigación científica en seres humanos como toda aquella que implica la **participación directa o el uso de datos biológicos, clínicos o sociales de personas**, con el fin de ampliar el conocimiento biomédico o sanitario.

2.2. Marco ético internacional

Los principales **documentos rectores internacionales** son:

1. **Código de Núremberg (1947)**: establece el principio del consentimiento voluntario.

- 2. **Declaración de Helsinki (WMA, 1964–2013):** norma ética fundamental para la investigación médica.
- 3. **Informe Belmont (EE. UU., 1979):** define tres principios éticos esenciales (respeto, beneficencia y justicia).
- 4. **Guías CIOMS (OMS, 2016):** orientaciones éticas internacionales adaptadas a países en desarrollo.

2.3. Principios éticos fundamentales

Principio	Descripción	Aplicación práctica
Respeto por las personas (autonomía)	Reconoce el derecho de cada individuo a decidir libremente sobre su participación.	Consentimiento informado, confidencialidad.
Beneficencia y no maleficencia	Obliga a maximizar beneficios y minimizar daños o riesgos.	Evaluación de riesgos y monitoreo constante.
Justicia	Exige distribución equitativa de los beneficios y cargas de la investigación.	Selección justa de participantes, sin discriminación.
Respeto por las comunidades	Implica considerar el contexto cultural y social de los grupos participantes.	Consulta comunitaria y devolución de resultados.
Integridad científica	Garantiza que los resultados sean veraces y reproducibles.	Evita falsificación, plagio o manipulación de datos.

3. Marco normativo y regulatorio en Chile

3.1. Normativa nacional vigente

Norma / institución	Contenido
Reglamento N.º 114/2011 (MINSAL)	Regula la investigación científica en seres humanos.
Ley N.º 20.120 (2006)	Establece normas sobre investigación científica en el ser humano, su genoma y prohíbe la clonación.
Ley N.º 19.628	Protección de datos personales y confidencialidad.
Ley N.º 20.584 (2012)	Regula los derechos y deberes de los pacientes.
Comités Ético-Científicos (CEC)	Órganos que evalúan y autorizan proyectos de investigación biomédica.
ANID (ex-CONICYT)	Promueve y financia investigaciones con criterios éticos y científicos.

3.2. Comité Ético-Científico (CEC)

Cada institución de salud o investigación que realice estudios en personas debe contar con un **CEC acreditado por el MINSAL**.

Funciones principales:

1. Evaluar la validez científica y ética de los protocolos.
2. Aprobar, rechazar o solicitar modificaciones.
3. Supervisar la ejecución de la investigación.
4. Garantizar la protección de los participantes.

Composición mínima: médicos, profesionales de salud, abogado, representante laico y un miembro no científico.

3.3. Clasificación del riesgo en investigación

De acuerdo con el Reglamento N.º 114/2011:

Nivel de riesgo	Descripción	Ejemplo
Sin riesgo	Estudios observacionales con fuentes públicas o anónimas.	Encuestas, revisión documental.
Riesgo mínimo	Procedimientos no invasivos de baja intensidad.	Cuestionarios, toma de muestras simples.
Riesgo mayor que el mínimo	Procedimientos invasivos o experimentales.	Ensayos clínicos con medicamentos.

Todos los estudios con **riesgo mayor o igual a mínimo** deben contar con la aprobación previa de un CEC.

4. Consentimiento informado

4.1. Definición

Es el **proceso voluntario, informado y documentado** mediante el cual una persona decide participar en una investigación, tras comprender sus objetivos, riesgos y beneficios.

4.2. Elementos esenciales

- Información clara y comprensible.
- Explicación de propósito, procedimientos, riesgos y beneficios.
- Derecho a retirarse sin consecuencias.
- Garantía de confidencialidad.
- Identificación del investigador responsable.

- Firma del participante o representante legal.

En personas menores de edad o con incapacidad legal, el consentimiento lo otorga su representante, y además debe obtenerse el **asentimiento del participante** cuando sea posible.

5. Beneficencia, no maleficencia y justicia en la práctica

5.1. Beneficencia

El investigador debe procurar que los resultados del estudio **beneficien a los participantes o a la sociedad**, asegurando un equilibrio entre riesgos y beneficios.

Ejemplo: Ensayos clínicos deben suspenderse si el riesgo supera el beneficio esperado.

5.2. No maleficencia

Implica evitar daño físico, psicológico o social. Se debe disponer de **seguros y medidas de protección** en caso de efectos adversos.

5.3. Justicia

Debe evitarse la explotación de grupos vulnerables. Los beneficios deben compartirse de forma equitativa.

Ejemplo: Estudios sobre VIH no deben centrarse solo en comunidades marginadas sin beneficio directo.

6. Confidencialidad y protección de datos

6.1. Principio de confidencialidad

Los datos personales y clínicos deben mantenerse **anónimos y seguros**. Solo el investigador responsable puede acceder a la información identificable.

6.2. Marco legal

- Ley N.º 19.628 sobre protección de datos personales.
- Ley N.º 20.584 sobre derechos del paciente.

- Prohibición de divulgar resultados individuales sin autorización.

6.3. Almacenamiento y uso secundario

Los datos pueden ser reutilizados solo si:

- Se cuenta con nuevo consentimiento, o
 - Están anonimizados y aprobados por el CEC.
-

7. Investigación con poblaciones vulnerables

El principio de **protección reforzada** aplica a menores, embarazadas, adultos mayores, personas privadas de libertad y comunidades indígenas.

Requisitos adicionales:

- Justificación científica del grupo.
 - Beneficio potencial directo.
 - Consentimiento del representante legal y asentimiento del participante.
 - Aprobación de CEC con expertos en el área específica.
-

8. Ética en ensayos clínicos y conflicto de intereses

8.1. Ensayos clínicos

Deben seguir las **Buenas Prácticas Clínicas (BPC)** de la OMS y la ICH (International Council for Harmonisation).

- Registro obligatorio en plataformas públicas (ej. ClinicalTrials.gov).
- Supervisión por el **Instituto de Salud Pública (ISP)** cuando se utilicen medicamentos.

8.2. Conflicto de intereses

Ocurre cuando los intereses financieros o personales pueden influir en el juicio del investigador.

Debe **declararse y gestionarse** en todo protocolo.

9. Rol del médico general y competencias en APS

Rol	Descripción	Ejemplo
Investigador clínico o comunitario	Participa en estudios locales de salud pública o intervención.	Ensayos de vacunas o programas APS.
Integrante de CEC	Evalúa ética y científicamente proyectos de su establecimiento.	Comité ético del hospital o SEREMI.
Educador ético	Explica principios éticos a pacientes y estudiantes.	Formación en consentimiento informado.
Vigilante del respeto ético	Denuncia prácticas investigativas no éticas.	Experimentos sin consentimiento.

El médico general debe combinar su **formación científica** con un **compromiso ético y humanista**, garantizando siempre la protección de la persona como eje central.

10. Errores comunes en EUNACOM

Error frecuente	Corrección conceptual
Pensar que basta con informar verbalmente al participante	El consentimiento debe ser por escrito y documentado .

Confundir consentimiento informado con autorización médica

El consentimiento es **voluntario, revocable y específico para investigación.**

Creer que los CEC son opcionales

Todo estudio con riesgo **debe ser aprobado** por un CEC acreditado.

Suponer que los datos clínicos pueden usarse libremente

Solo con consentimiento o anonimización.

Ignorar conflictos de interés en investigación

Deben declararse para mantener la integridad científica.

11. Complicaciones y desafíos actuales

- **Aceleración tecnológica:** uso de inteligencia artificial y big data plantea nuevos dilemas éticos.
- **Investigación genómica:** manejo de datos sensibles y consentimiento ampliado.
- **Desigualdad global:** estudios trasladados a países con menos regulación.
- **Presión por publicar:** puede generar sesgos o violaciones de integridad científica.

Desafío futuro: fortalecer la **educación ética en investigación** en la formación médica y fomentar la **cultura de responsabilidad científica** en todos los niveles asistenciales.

12. Referencias ministeriales y técnicas

- MINSAL (2011). Reglamento N.º 114/2011 sobre Investigación en Seres Humanos.
- Ley N.º 20.120 (2006). Investigación científica y genoma humano.
- Declaración de Helsinki (WMA, 2013).

- CIOMS/OMS (2016). Guías éticas internacionales para investigación biomédica.
 - Ley N.º 19.628 y Ley N.º 20.584.
 - OPS/OMS (2023). Ética en salud pública e investigación.
-

13. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. Los **principios éticos fundamentales** (autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia) rigen toda investigación en salud.
2. El **consentimiento informado** es un proceso esencial, libre, informado y documentado.
3. Todo estudio con riesgo debe contar con la **aprobación previa de un Comité Ético-Científico acreditado**.
4. La **confidencialidad y protección de datos personales** son obligaciones legales y éticas.
5. Los **grupos vulnerables** requieren protección especial y beneficios directos de la investigación.
6. La **integridad científica** implica veracidad, transparencia y ausencia de conflictos de interés.
7. El médico general debe actuar siempre como **garante de la dignidad y derechos humanos**, priorizando el bienestar de las personas sobre los intereses científicos o económicos.